

CAPÍTULO 13.10

Coqueluche

PERFIL EUNACOM 1.05.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Coqueluche**, también conocido como **tos ferina** o **tos compulsiva**, es una enfermedad infectocontagiosa inmunoprevenible incluida en el **Plan Nacional de Inmunizaciones** (PNI). A pesar de la vacunación, persisten casos anuales y brotes cíclicos. Su gravedad es inversamente proporcional a la edad, siendo especialmente severa en **lactantes menores de 3 meses** y personas no vacunadas.

Etiología y Definiciones

La causa principal es la bacteria gramnegativa **Bordetella pertussis**.

- **Agentes causales:** Principalmente *B. pertussis*, pero también *B. parapertussis* y otras especies menos frecuentes.
- **Síndrome Coqueluchoideo:** Cuadro clínico similar al coqueluche pero causado por otros agentes como:
 - **Mycoplasma**
 - Adenovirus
 - Virus Respiratorio Sincicial (VRS)
 - Aspiración de cuerpo extraño

NOTA CLÍNICA

El término "Coqueluche" se reserva específicamente para el síndrome clínico causado por bacterias del género *Bordetella*.

Cuadro Clínico

La enfermedad se desarrolla en tres etapas clásicas. Su duración total puede ser de varios meses (la "tos de los 100 días").

TABLA 13.10.1: FASE VS DURACIÓN

FASE	DURACIÓN	CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Catarral	1 - 2 semanas	Cuadro indistinguible de un resfrió común. Rinorrea acuosa (no purulenta) y ausencia de fiebre .
Paroxística	2 - 8 semanas	Tos quintosa, accesos de tos, "gallito" inspiratorio, emesis post-tusiva.
Convalecencia	Semanas a meses	Disminución gradual de la frecuencia e intensidad de la tos.

Características de la Fase Paroxística

Es la etapa más característica y donde se realizan la mayoría de los diagnósticos: - **Tos Quintosa:** Accesos de tos bruscos (al menos 5 golpes de tos seguidos) que impiden la respiración. - **Gallito Inspiratorio:** Estridor inspiratorio al final del acceso de tos. - **Signos asociados:** Petequias en la cara (por esfuerzo), hemorragias subconjuntivales. - **Tos Emetizante:** Tos que provoca el vómito (muy sugerente de coqueluche en adultos y niños).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En **lactantes pequeños** (menores de 3 meses) o niños no vacunados, el coqueluche puede presentarse únicamente como **apneas respiratorias**. Toda apnea sin causa clara en un lactante debe hacer sospechar coqueluche.

Diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero requiere confirmación microbiológica.

- **PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa):** Es la técnica de elección actual por su alta sensibilidad y rapidez. Ha desplazado a la inmunofluorescencia directa (IFD).
- **Cultivo:** Se realiza en medios especiales (Bordet-Gengou). Es muy específico pero poco sensible, ya que *Bordetella* es una bacteria

"fastidiosa" que muere fácilmente durante el transporte.

- **Serología (IgG contra toxina pertussis):** Útil para diagnóstico retrospectivo en pacientes que llevan más de 4 semanas con síntomas, cuando la PCR y el cultivo suelen ser negativos.
- **Hemograma:** Es muy característico encontrar una **linfocitosis absoluta** importante. Puede llegar a niveles de **reacción leucemoide** (>50.000 linfocitos/mm³).
- **Radiografía de Tórax:** Suele ser normal o mostrar infiltrados inespecíficos. Se solicita principalmente para descartar complicaciones (neumonía) o diagnósticos diferenciales (cuerpo extraño).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante un lactante con sospecha de coqueluche, siempre se debe interrogar por **contactos con tos** en el hogar. La vacuna protege contra la enfermedad grave, pero los adultos vacunados pueden tener cuadros leves de tos prolongada y contagiar al lactante.

Tratamiento

El tratamiento de elección son los **macrólidos**. El objetivo principal es acortar el periodo de contagio y, si se inicia precozmente, disminuir la duración de los síntomas.

Esquemas Antibióticos

1. **Azitromicina (Elección):** - Dosis: **10 mg/kg/día** (máximo 500 mg) por **5 días**. - Ventaja: Dosificación sencilla y mejor tolerancia. 2. **Claritromicina:** Por 10 a 14 días. 3. **Eritromicina:** Por 10 a 14 días. 4. **Cotrimoxazol:** Alternativa en caso de alergia o intolerancia a macrólidos.

EUNACOM CRITERIOS

El tratamiento antibiótico es más efectivo cuando se inicia en la **fase catarral**. Si se inicia después de **21 días** de síntomas, la evidencia muestra que ya no altera el curso de la enfermedad ni disminuye el contagio, aunque en niños y pacientes de riesgo se suele indicar de todas formas.

Manejo y Complicaciones

- **Hospitalización:** Recomendada en lactantes menores de 3-6 meses, pacientes con apneas, cianosis o dificultad respiratoria severa. - **Antitusígenos:** No han demostrado utilidad y no se recomiendan de rutina. - **Complicaciones:** - Neumonía (causa principal de muerte). - Encefalopatía y convulsiones (por hipoxia o toxina). - Desnutrición o deshidratación por vómitos repetidos.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología de las convulsiones en el coqueluche es multifactorial, involucrando hipoxia durante los paroxismos, microhemorragias cerebrales y los efectos de la toxina pertussis en el sistema nervioso central.

Manejo de Contactos

El coqueluche requiere el manejo de los contactos cercanos para cortar la cadena de transmisión. Esto incluye profilaxis antibiótica (generalmente con azitromicina) independientemente del estado vacunal, especialmente si hay lactantes o embarazadas en el grupo de contacto.

Prevención y Profilaxis: Coqueluche

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Lactante de 2 meses, no vacunado, consulta por episodios repetidos de apnea sin otra sintomatología respiratoria evidente. La madre refiere tos de 2 semanas de evolución. El examen pulmonar del lactante es normal. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica principal y el examen de elección?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Coqueluche. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Causado por *Bordetella pertussis*; más grave en lactantes <3 meses y no vacunados
- Tres fases: catarral (1-2 semanas), paroxística (2-8 semanas) y convalecencia (semanas a meses)
- Fase catarral: resfriado con rinorrea acuosa persistente y sin fiebre
- Fase paroxística: tos quintosa, gallito inspiratorio, tos emetizante, apneas en lactantes
- Las apneas en lactantes pueden ser el único síntoma y son signo de gravedad
- Diagnóstico de elección: PCR para *Bordetella pertussis*; cultivo es poco sensible (bacteria fastidiosa)
- Hemograma con linfocitosis marcada, incluso reacciones leucemoides
- Tratamiento: azitromicina 10 mg/kg/día por 5 días; alternativa cotrimoxazol
- El tratamiento sirve para reducir contagio y acortar síntomas solo si se da precozmente (<21 días)
- Contacto sintomático de caso confirmado se maneja como caso confirmado

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (COQUELUCHE)**PREGUNTA 1**

Lactante de 2 meses, no vacunado, consulta por episodios repetidos de apnea sin otra sintomatología respiratoria evidente. La madre refiere tos de 2 semanas de evolución. El examen pulmonar del lactante es normal. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica principal y el examen de elección?

- A)** Bronquiolitis por VRS; panel viral por inmunofluorescencia
- B)** Coqueluche; PCR para *Bordetella pertussis*
- C)** Apneas del prematuro; polisomnografía
- D)** Reflujo gastroesofágico; pHmetría esofágica
- E)** Epilepsia; electroencefalograma

PREGUNTA 2

Niño de 4 años, vacunación al día, con tos de 3 semanas de evolución que se presenta en accesos de más de 5 golpes seguidos con gallito inspiratorio y vómitos post-acceso. Examen pulmonar normal, afebril. Hemograma: leucocitos 28.000 con 75% linfocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Asma bronquial
- B)** Leucemia linfoblástica aguda
- C)** Coqueluche
- D)** Neumonía atípica por *Mycoplasma*
- E)** Cuerpo extraño en vía aérea

PREGUNTA 3

Adolescente de 15 años con diagnóstico confirmado de coqueluche por PCR. Lleva 25 días de síntomas y persiste con tos importante. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto al tratamiento antibiótico?

- A)** Iniciar azitromicina 10 mg/kg/día por 5 días de forma urgente
- B)** No indicar antibiótico; después de 21 días ya no tiene beneficio demostrado
- C)** Indicar eritromicina por 14 días ya que es más potente que la azitromicina
- D)** Indicar antitusivos potentes para controlar los accesos de tos
- E)** Solicitar IgG anti-toxina pertussis antes de decidir tratamiento

RESUMEN: COQUELUCHE

El coqueluche (tos ferina o tos compulsiva) es una enfermedad incluida en el Plan Nacional de Inmunizaciones causada por *Bordetella pertussis*. Otras bordetelas (*parapertussis*) y agentes como *Mycoplasma*, adenovirus y VRS pueden producir un síndrome coqueluchoideo similar. La enfermedad es más severa en lactantes menores de 3 meses no vacunados. La clínica se divide en tres fases. La fase catarral (1-2 semanas) es indistinguible de un resfrío común, aunque la rinorrea tiende a mantenerse acuosa sin volverse purulenta y habitualmente cursa sin fiebre. La fase paroxística (2-8 semanas) es la más característica, con tos quintosa (accesos de al menos 5 golpes de tos seguidos), gallito inspiratorio, petequias faciales por esfuerzo tusivo, náuseas y vómitos (tos emetizante). En lactantes pequeños, las apneas pueden ser el único síntoma y constituyen un signo de gravedad. En casos severos pueden presentarse convulsiones. La fase de convalecencia presenta tos residual que puede persistir semanas a meses. El diagnóstico se confirma con PCR para *Bordetella pertussis*, que ha reemplazado a la inmunofluorescencia directa como examen de elección. El cultivo se solicita complementariamente pero es poco sensible por tratarse de una bacteria fastidiosa. La IgG anti-toxina pertussis sirve para diagnóstico tardío (>4 semanas de síntomas). El hemograma muestra linfocitosis marcada, pudiendo llegar a reacciones leucemoides. Un contacto sintomático de un caso confirmado se considera caso confirmado. El tratamiento de elección es azitromicina 10 mg/kg/día por 5 días. Alternativas son claritromicina y eritromicina (10-14 días), o cotrimoxazol ante alergia a macrólidos. El tratamiento reduce el contagio y acorta los síntomas solo si se administra tempranamente; después de 21 días de síntomas ya no tiene beneficio demostrado, aunque en niños y pacientes de riesgo se indica igualmente. Los antitusivos no han demostrado eficacia.